

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

PERMITOS Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO SEP 22 '26 AM 11:42 *gmc*

20 ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 707

INFORME POSITIVO

22

21 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto de la Cámara 707**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El **Proyecto de la Cámara 707** propone enmendar los Artículos 1, 2, y 3 de la Ley Núm. 212-2008, a los fines de añadir la definición de "co-morbilidad"; atemperar las disposiciones de la Ley 212-2008 a la Declaración Conjunta 2022 de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica ("ASMBS" por sus siglas en inglés) y Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos ("IFSO" por sus siglas en inglés) relacionadas con las recomendaciones clínicas y cubierta de beneficios para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica según se establece en dicha legislación, que no sean incompatibles con los parámetros establecidos por el gobierno federal para el Programa Medicaid; establecer que las pólizas de seguros cobijadas al amparo de esta Ley tendrán requisitos uniformes; prohibir que las organizaciones de seguros de salud o demás entidades mencionadas en esta Ley impongan consultas previas con profesionales de la salud que no sean los recomendados por el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica al momento de solicitar dicha preautorización, como pre-requisito para

brindar al paciente asegurado la preautorización establecida al amparo de esta Ley; establecer que el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica determinará aquellos exámenes médicos que serán necesarios realizarse a cada paciente por individual antes de realizarse la cirugía bariátrica recomendada, en adición con la preparación quirúrgica necesaria para que el paciente mejore su co-morbilidad y los problemas encontrados bajo los cuales no lograron su cometido que llevan a la recomendación del procedimiento de cirugía bariátrica a utilizarse con dicho paciente; establecer que la instalación de salud en que se realizará la cirugía bariátrica debe contar con la acreditación del Programa Conjunto conocido como el Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP, por sus siglas en inglés), el cual es una iniciativa conjunta de acreditación establecida por la American College of Surgeons (A.C.S.) y la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (A.S.M.B.S.) dedicadas específicamente en acreditar centros con programas de cirugía bariátrica; autorizar al Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, al Comisionado de Seguros y a la Administración de Seguros de Salud a aprobar la reglamentación necesaria para llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad ineludible de garantizar el acceso a los servicios de salud y velar por el ofrecimiento eficiente de los mismos. Cónsono con la política pública de procurar servicios de salud ágiles, accesibles y eficaces a los puertorriqueños, es necesario el atemperar la legislación existente a las nuevas tendencias científicas relacionadas con las recomendaciones clínicas para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica.

A tales efectos, para el año 2008, se aprobó la Ley 212, la cual requiere que se establezca como mandatorio en todo ofrecimiento de contrato de seguros de salud, sea privado o gubernamental, que se incluya dentro de su póliza el pago de la cubierta de servicios clínicos, para el tratamiento de la obesidad mórbida y el síndrome metabólico con la cirugía bariátrica, siempre y cuando un médico y hospital especializado en medicina bariátrica y/o cirugía bariátrica lo estipule necesario, así como para el pago de los procedimientos, diagnósticos, tratamientos y medicamentos posteriores a la cirugía. Ya

han transcurrido más de quince (15) años desde su establecimiento, y la misma no ha sido revisada ni atemperada a las nuevas tendencias científicas relacionadas con el tratamiento de la condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico.

Un ejemplo de esto es el siguiente: para el año 2022, los líderes de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS) y de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO) firmaron una Declaración Conjunta, en donde utilizando la información científica disponible actualmente sobre la cirugía metabólica y bariátrica y sus indicaciones, establecieron que la cirugía metabólica y bariátrica está recomendada para los siguientes individuos con obesidad determinada por clases de obesidad, a saber: personas con obesidad clase 1, 2, 3 según el BMI: Clase 1- de 30.0 a 34.9 BMI, Clase 2- de 35 a 39.9 BMI y Clase 3 de mayor o igual a 40 BMI, con los siguientes parámetros clínicos, según les apliquen:

- 
1. aquellos con Índice de Masa Corporal (BMI) igual o mayor a 35 kg/m² sin importar presencia, ausencia o severidad de condiciones comórbidas.
 2. aquellos con Diabetes tipo 2 con BMI igual o mayor a 30kg/m².
 3. aquellos individuos con BMI de 30-34.9 kg/m² que no logren pérdida de peso sustancial o duradera para mejorar sus co-morbilidades con métodos no-quirúrgicos.
 4. aquellos individuos que necesiten la cirugía bariátrica como puente para otras intervenciones quirúrgicas tales como artroplastias, hernias y trasplantes de órganos.
 5. La obesidad es una enfermedad crónica que requiere manejo vitalicio después de la operación primaria. Esto incluye procedimientos revisionales y otras terapias incluyendo intervenciones endoscópicas y farmacológicas para lograr el efecto deseado en el tratamiento.
 6. Las nuevas guías afirman además que "la cirugía metabólica y bariátrica es actualmente el tratamiento basado en evidencia más eficaz para la obesidad en todas las clases de IMC" y que "los estudios con seguimiento a largo plazo, publicados en las décadas posteriores a la Declaración de Consenso del NIH de 1991, han demostrado sistemáticamente que la cirugía metabólica y bariátrica produce resultados de pérdida de peso superiores en comparación con los tratamientos no quirúrgicos".

En cuanto al Plan de Salud Gubernamental, la ASES o el Programa Medicaid podrán establecer los requisitos necesarios para la cubierta del servicio de Cirugía Bariátrica, de manera que se proteja la sostenibilidad de este.



Por ende, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el enmendar la Ley 212-2008, en reconocimiento de la necesidad de que la Ley Núm. 212-2008 no se atempera a la realidad actual de la práctica médica en donde los pacientes puedan beneficiarse de las nuevas tendencias científicas existentes para atender sus problemas de obesidad mórbida y de síndrome metabólico. Por consiguiente con la aprobación de esta Ley, se añade la definición de "co-morbilidad", además de atemperar las disposiciones de la Ley 212-2008 a la Declaración Conjunta 2022 de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica y Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos relacionadas con las recomendaciones clínicas para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida, según las clasificaciones clínicas de Obesidad Clase 1, 2 o 3, co-morbilidades y/o y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica, según se establece en dicha legislación y que no sean incompatibles con los parámetros establecidos por el gobierno federal para el Programa Medicaid; establecer que el paciente no necesitará de un referido médico por parte de su médico primario para poder acceder al médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica para consultar o comenzar un plan de tratamiento para atender su condición de obesidad mórbida o de síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica cuando sea médicamente necesario con el fin de evitar retrasar el acceso oportuno del paciente al tratamiento médico adecuado de su enfermedad dentro de las Clases de Obesidad y/o co-morbilidades establecidas y sustentadas en el criterio médico del médico especialista para impedir el poner en alto riesgo la vida del paciente; entre otros asuntos.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del P. de la C. 707, la Honorable Comisión de Salud del Senado evaluó los comentarios sobre la medida de diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales explicativos utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), la Oficina del Procurador del Paciente, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), MCS, Advantage, MMM Holdings, LLC., ASMBS Access to Care Representative de

Puerto Rico y el "letter of support" de la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). Así como el memorial del Centro Médico Episcopal San Lucas remitido a la Cámara de Representantes. Además, examinamos el Informe Positivo sobre la medida y el Entirillado Electrónico rendido por la Comisión de Salud de dicho Ilustre Cuerpo.

Cabe destacar, que la Comisión también solicitó comentarios sobre la pieza legislativa a la Asociación de Hospitales, la Asociación Médica, al Colegio de Médicos Cirujanos, First Medical, Grupo Paciente Bariátricos Nuevo Amanecer, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Ponce Health Science University, la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, Triple-S y la Universidad de Puerto Rico; no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.



A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD (DS)

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el **Departamento de Salud (DS)**, presentó su memorial explicativo luego de consultar con el Programa Medicaid adscrito a la secretaría Auxiliar para la Coordinación de Servicios de Asistencia en Salud (SACSAS), por conducto de su Secretario, Victor M. Ramos Otero, expresándose a favor de la aprobación de la medida tras haber acogido sus recomendaciones en la Cámara de Representantes.

El Departamento de Salud relató haber manifestado su oposición a la aprobación de la medida mediante memorial explicativo con fecha del 11 de agosto de 2025, dirigido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Indicó que sus reservas no eran con el propósito loable de la medida, sino con su impacto sobre el Plan de Salud Gubernamental. Detalló que, en síntesis, sus planteamientos eran que: (1) en cuanto a los servicios cubiertos por el Programa Medicaid, deben poder implementarse restricciones distintas a las que rigen para las organizaciones y compañías de seguros privadas; (2) en el Plan de Salud Gubernamental la cirugía bariátrica debe limitarse, como norma general, a una intervención por paciente, permitiéndose una segunda intervención solo en circunstancias excepcionales, cuando exista necesidad médica debidamente justificada y documentada; y (3) ante el financiamiento federal limitado del Programa en Puerto Rico,

no resultaba viable flexibilizar los criterios de cubierta sin salvaguardas expresas para la sostenibilidad del Plan.

No obstante, aclaró, que posteriormente, durante el trámite legislativo en la Cámara de Representantes, la Agencia tuvo la oportunidad de revisar el borrador de Entirillado Electrónico de la medida y sometió recomendaciones de lenguaje específicas, dirigidas a que toda extensión de beneficios bajo la Ley 212-2008 quedara supeditada, en el caso del Plan de Salud Gubernamental, a que el servicio esté en cubierta y a que se cumplan los requisitos establecidos por la Administración de Seguros de Salud (ASES) o el Programa Medicaid para cubrirlo y pagarlo.

En cuanto al Texto de Aprobación Final de la Cámara de Representantes, el cual posteriormente fue remitido a la Comisión de Salud de del Senado y es objeto de evaluación, informó que las enmiendas presentadas por el Departamento de Salud fueron acogidas en su totalidad. En particular:

- 
- Exposición de Motivos. Se incorporó un párrafo que dispone que, “[e]n cuanto al Plan de Salud Gubernamental, la ASES o el Programa Medicaid podrán establecer los requisitos necesarios para la cubierta del servicio de Cirugía Bariátrica, de manera que se proteja la sostenibilidad de este”. Ello recoge el principio rector de la posición del Departamento.
 - Artículo 1(b) – definición de cirugía bariátrica. Se añadió que, en el caso del Plan de Salud Gubernamental, la cubierta del procedimiento de balón intragástrico “estará sujeto a que esté en cubierta y se cumplan con los requisitos establecidos por ASES o el Programa Medicaid para cubrir y pagar el mismo”.
 - Artículo 2 – acceso al especialista. Se eliminó la disposición, y la referencia correspondiente en el título, que establecía que el paciente no necesitaría de un referido de su médico primario para acceder al médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica. Con ello se preserva el modelo de coordinación de cuidado del Plan de Salud Gubernamental.
 - Artículo 3(a) – número de intervenciones. Se eliminó el lenguaje que reconocía la posibilidad de “múltiples intervenciones a lo largo del tiempo” y la cubierta por “recurrencia de enfermedad”. En su lugar, el texto aprobado dispone que “[u]na

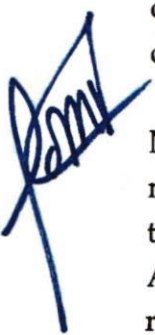
segunda intervención sólo podrá ser autorizada en circunstancias excepcionales, cuando exista una necesidad médica debidamente justificada" y que, "[e]n el caso del Plan de Salud del Gobierno, una segunda intervención podría autorizarse, siempre y cuando cumpla con los requisitos ya establecidos para esos fines". Este lenguaje es cónsono con la recomendación central de nuestro memorial del 11 de agosto de 2025.

- 
- Artículo 3(c) – preautorización. Se añadió la frase "y lo establecido por el Plan de Salud Gubernamental para cubrir y pagar el servicio" como parámetro para la preautorización, según recomendado.
 - Artículo 3(d) – determinación del especialista. Se añadió, al final del inciso, la condición de que el paciente "cumpla con los requisitos establecidos por ASES o el Programa Medicaid para cubrir y pagar el mismo".
 - Artículo 3(e)(6) – instalación de salud. Se incorporó un nuevo requisito para la instalación donde se realice la cirugía: "Cumplir con los requisitos del Plan de Salud Gubernamental para cubrir y pagar el servicio".
 - Artículo 3(f) – requisitos uniformes. Se añadió la excepción solicitada, de modo que la uniformidad de requisitos entre pólizas públicas y privadas aplicará "excepto en el caso del Plan de Salud Gubernamental que puede establecer requisitos diferentes para cubrir o pagar el servicio".

Asimismo, el Departamento de Salud señaló que el texto aprobado mantiene el requisito de que la instalación de salud cuente con la acreditación del Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP), iniciativa conjunta del American College of Surgeons y la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, junto con los requisitos de disponibilidad de equipo médico institucional, equipo e instrumentos especializados, servicio de ambulancia, protocolos escritos y programas de calidad automatizados cuya información e índices establecerá el Departamento de Salud por reglamento. Enfatizó, que estos requisitos constituyen salvaguardas apropiadas para la calidad de la atención y la seguridad clínica del paciente bariátrico.

El Departamento es de la opinión que, con la incorporación de estas enmiendas, la medida logra un balance adecuado entre dos objetivos legítimos: por un lado, atemperar la Ley 212-2008 a la evidencia científica vigente, de manera que los pacientes con obesidad mórbida y síndrome metabólico puedan beneficiarse de los criterios clínicos actualizados; y por otro, preservar la facultad de ASES y del Programa Medicaid para establecer los requisitos de cubierta y pago que resulten necesarios para proteger la sostenibilidad fiscal del Plan de Salud Gubernamental, en cumplimiento con los parámetros del gobierno federal.

De otra parte, destacó que, conforme a los contratos entre ASES y las organizaciones de cuidado coordinado, todo procedimiento médicamente necesario para tratar la obesidad mórbida ya se considera un servicio cubierto y no se considera un procedimiento cosmético, por lo que la medida, según enmendada, no altera la base contractual vigente del Plan.



No obstante, el Departamento de salud realizó ciertas recomendaciones técnicas para una mejor implementación de la medida: en primer lugar, propuso que se uniformase el uso del término "Plan de Salud Gubernamental" a lo largo del articulado, toda vez que el Artículo 3(a) utiliza la variante "Plan de Salud del Gobierno". De igual forma, sugirió revisar la redacción del Artículo 3(c) para que la referencia a que el paciente "ha fallado" en los métodos no quirúrgicos quede expresada con mayor claridad. Resaltó, que se trata de ajustes de forma que no alteran el fondo de la medida.

En conclusión, el Departamento de salud endosó el P. de la C. 707, tras haberse acogido en su totalidad las enmiendas y recomendaciones sometidas ante la Cámara de Representantes.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Administración de Seguros de Salud (ASES)** quien presentó su memorial explicativo por conducto de su Director Ejecutivo, el Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario, expresándose a favor de la medida, sujeto a que se acoja su recomendación.

La ASES reconoció la importancia de atemperar la Ley Núm. 212-2008, tradicionalmente conocida como "Ley para Requerir que en Todo Contrato de Seguros de Salud se Incluya dentro de su Póliza el Pago de la Cubierta de Servicios Clínicos para el Tratamiento de la

Obesidad Mórbida y el Síndrome Metabólico con la Cirugía Bariátrica", a la realidad actual de la práctica médica para que los pacientes puedan beneficiarse de las nuevas tendencias científicas existentes para atender problemas de obesidad mórbida y síndrome metabólico, por lo que entiende la relevancia de las enmiendas propuestas por el P. de la C. 707.



Relató que, en su análisis de la medida cuando se encontraba ante la consideración de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, expuso que lo propuesto inicialmente representaría un riesgo para la subvención de los fondos federales del Programa Medicaid que sostienen el Plan Vital y destacó que el P. de la C. 707 presentaba varios retos operacionales, regulatorios y fiscales. En particular, mencionó que la eliminación del referido del médico primario para acceder a los médicos especialistas en medicina o en cirugía bariátrica estaba en contraposición al modelo de cuidado bajo el Plan Vital, el cual es un modelo de cuidado coordinado cuyo eje principal es el médico primario como manejador del cuidado del paciente. Por lo tanto, sostuvo que la eliminación que se proponía del requisito de referido médico no abonaba a mantener la costo-efectividad de los servicios utilizados bajo el Plan Vital, además de que afectaría la integración del cuidado y el buen manejo de los servicios de salud provistos al beneficiario.

ASES destacó también que los tratamientos para la obesidad mórbida están actualmente cubiertos bajo el Plan Vital, siempre y cuando no sean para fines estéticos. Detalló, que, específicamente, el contrato entre la ASES y las organizaciones de cuidado coordinado (MCOs) que ofrecen servicio bajo el Plan Vital dispone lo siguiente:

7.3.1 In no instance shall the Contractor cover experimental or cosmetic procedures, except as required by the Puerto Rico Patient's Bill of Rights Act or any other Federal or Puerto Rico law or regulation. Breast reconstruction after a mastectomy and surgical procedures that are determined to be Medically Necessary to treat morbid obesity shall not be regarded as cosmetic procedures.

[...]

7.5.2.1.3 Cosmetic or experimental surgery and treatment, solely to correct defects in the physical appearance, excluding also hospitalization, medical surgical services and complications associated with this procedure, regardless of other medical justification, except as required by any federal or Puerto Rico law or regulation. Breast reconstruction after a mastectomy and surgical procedures that are

determined to be medically necessary to treat morbid obesity shall not be regarded as cosmetic procedures;

[...]

7.5.6.2 While cosmetic procedures shall be excluded from Covered Services, breast reconstruction after a mastectomy and surgical procedures Medically Necessary to treat morbid obesity shall not be considered to be cosmetic procedures.

Acentuó que, conforme con lo establecido en el contrato entre los MCOs y la ASES, los tratamientos para atender la obesidad mórbida ya forman parte de la cubierta del Plan Vital, sin embargo, el acceso a estos servicios está cimentado en el modelo de cuidado coordinado, siendo necesarios los referidos del médico primario.



A base de lo anterior, ASES señaló que, en aquella etapa del trámite legislativo, recomendó que enmendara el P. de la C. 707 para excluir de su aplicación al Plan Vital para así evitar una crisis fiscal que pueda poner en riesgo los servicios de salud ofrecidos a todas las personas médico indigente de la Isla. Pero, luego de examinar el texto aprobado, ahora ante la consideración de la Comisión de Salud del Senado, observó que se acogieron sus recomendaciones. Ilustró que, tanto en la Exposición de Motivos del Proyecto como en varias de las disposiciones se reconoce que bajo el Plan de Salud de Gobierno o Plan Vital se establecerán aquellos requisitos que protejan la sostenibilidad del Programa y sujeto a los requisitos establecidos por el Programa Medicaid y por la ASES. Incluso, reconoció que en la Sección 3, la enmienda propuesta al inciso f dispone que: "La póliza de seguro, sea pública o privada, tendrá requisitos uniformes a tono con lo dispuesto en esta Ley, excepto en el caso del Plan de Salud Gubernamental que puede establecer requisitos diferentes para cubrir o pagar el servicio".

De igual forma, ilustró que se eliminó el lenguaje alusivo a la exclusión del referido médico del médico primario para el acceso a especialistas en medicina o cirugía bariátrica, con lo cual concurre. No obstante, advirtió que, en la última oración del último párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto aún permaneció una referencia a la exclusión del referido médico, por lo cual entiende que la misma debe ser eliminada.

En conclusión, ASES reconoció que se acogieron los cambios sugeridos anteriormente para no impactar las operaciones del Plan Vital. Por consiguiente, indicó no tener reparo

en la aprobación de la medida, sujeto a que se atienda la última recomendación antes señalada.

OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS (OCS)

Recibimos, de igual forma, la ponencia de la **Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)** la cual presentó su memorial explicativo por conducto de su Comisionada, la Lcda. Suzette Del Valle Lecaroz, en el cual expresó su apoyo a la aprobación de la medida, reconociendo que sus fines son loables y están alineados con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de ofrecer servicios de salud ágiles, eficaces y asequibles.



La OCS coincidió con el objetivo de enmendar la Ley Núm. 212-2008 para atemperar las cubiertas de cirugía bariátrica a los descubrimientos científicos recientes, que validan este procedimiento como el tratamiento más eficaz para la obesidad mórbida y el síndrome metabólico, condiciones que afectan a un sector de entre el 8% y 10% de la población puertorriqueña. Enfatizó que el tratamiento adecuado no solo mejora sustancialmente la calidad de vida de los pacientes, sino que también representa un beneficio económico a largo plazo para los planes médicos debido a la reducción de gastos subsiguientes en servicios de salud.

Entre las disposiciones fundamentales con las que concurre, se destaca la incorporación de la definición de "co-morbilidad" en el Artículo 1 de la Ley 212. La OCS sostuvo que la adición de este término elimina barreras burocráticas innecesarias en el acceso a la cirugía, facilitando que pacientes que padecen de dos o más enfermedades relacionadas con la obesidad mórbida cualifiquen directamente para el procedimiento, lo que disminuye a su vez los costos de las aseguradoras en hospitalizaciones y medicamentos. De igual forma, apoya la prohibición en el Artículo 2 de exigir consultas previas con profesionales de la salud que no sean expresamente recomendados por el especialista en medicina o cirugía bariátrica al tramitar la preautorización. Planteó que esta medida evita retrasos administrativos perjudiciales para el paciente, acorta los periodos de espera y genera ahorros directos para las aseguradoras al mitigar consultas redundantes.

Adicionalmente, la OCS formuló dos recomendaciones puntuales para optimizar el alcance integral del Proyecto:

1. En primer lugar, propuso la inclusión de disposiciones que garanticen la cubierta de procedimientos reconstructivos, como la paniclectomía, para remover el exceso de piel tras una pérdida masiva de peso. Fundamentó esta recomendación

en que tales intervenciones no son estéticas, sino médicamente necesarias para tratar complicaciones recurrentes como la dermatitis crónica, infecciones y limitaciones funcionales, en cumplimiento con guías de Medicare, Medicaid y la ASPS.

2. En segundo lugar, sugirió incorporar programas de ejercicio supervisado y terapias complementarias de manejo pre y postoperatorio, tomando como referencia modelos exitosos de Medicaid en estados como Nueva York y Massachusetts, con el fin de promover una pérdida de peso sostenible y una óptima utilización de los servicios médicos cubiertos.



Finalmente, la OCS enfatizó en la importancia de que la Comisión asegure rigurosamente la compatibilidad de todas las enmiendas propuestas en el Proyecto con el marco regulatorio y los requisitos legales estrictos exigidos por los programas de salud financiados con fondos del gobierno federal de los Estados Unidos, particularmente Medicare y Medicaid. Concluyó sus comentarios concediendo deferencia a las observaciones y comentarios adicionales que presenten la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Salud de Puerto Rico por entender que el Proyecto puede incidir en asuntos que les conciernen.

OFICINA DEL PROCURADOR DEL PACIENTE (OPP)

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, la **Oficina del Procurador del Paciente (OPP)**, presentó su memorial explicativo suscrito por su Procuradora, Edna I. Díaz De Jesús, expresándose a favor de la aprobación de la medida. Puntualizó, que la obesidad representa un problema crítico de salud pública mundial que influye de forma adversa en la calidad de vida, el sueño y el movimiento de los ciudadanos, aumentando significativamente los riesgos de padecer diabetes tipo 2, cardiopatías, afecciones óseas y diversos tipos de cáncer.

Para la OPP, las modificaciones propuestas garantizan un proceso de atención médica mucho más justo, ágil y estrictamente centrado en las necesidades del paciente. Considera que medular la prohibición categórica a las organizaciones de seguros de salud de imponer consultas previas o referidos obligatorios por parte del médico primario como requisito para acceder a un especialista en medicina o cirugía bariátrica. Catalogó esta exigencia como una barrera administrativa histórica que retrasa de forma injustificada el cuidado clínico de personas con obesidad mórbida, por lo que es de la opinión que su

eliminación representa un avance sustancial en favor de la accesibilidad y la equidad en los servicios de salud de la Isla.

Vislumbró como positivo la incorporación formal del concepto de "co-morbilidad" dentro del estatuto legal, catalogándolo como un elemento clínico de carácter esencial para definir con precisión científica las condiciones médicas que justifican de forma plena una intervención bariátrica. Señaló, que esta actualización técnica logra alinear de manera perfecta la legislación de Puerto Rico con los descubrimientos científicos globales y las recomendaciones internacionales más recientes. Al mismo tiempo, avaló que se obligue a las aseguradoras a mantener requisitos de cubierta totalmente uniformes, lo cual promoverá una mayor transparencia institucional y evitará disparidades o desigualdades de acceso entre los afiliados de distintos planes médicos.



De igual manera, la OPP defiende y salvaguarda la autonomía profesional del médico especialista en cirugía bariátrica al establecer que será este profesional, y ningún otro actor del sistema, quien determinará los exámenes médicos y evaluaciones preparatorias necesarias para cada paciente de forma individualizada. Asimismo, rechazó la imposición de criterios o guías arbitrarias por parte de las compañías aseguradoras u otras entidades administrativas que pretendan interferir en el criterio clínico. Argumentó, que, con este enfoque, se garantiza que la preparación quirúrgica responda exclusivamente a mejorar las comorbilidades particulares detectadas en el paciente y a solucionar aquellos problemas de salud específicos por los cuales los tratamientos tradicionales previos no lograron su cometido.

Por otra parte, reconociendo los severos retos de infraestructura y la escasez de equipo especializado que enfrentan los centros hospitalarios en el país, la OPP respaldó plenamente la inclusión de requisitos rigurosos de seguridad e infraestructura hospitalaria dentro del inciso (e) del Artículo 3 de la Ley. Entre estas exigencias obligatorias, la OPP destacó que cualquier instalación de salud que aspire a ofrecer cirugías bariátricas debe poseer la acreditación formal del Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP). Acentuó, que dicha acreditación conjunta, otorgada por la American College of Surgeons (A.C.S.) y la ASMBS, es reconocida a nivel federal por agencias como Medicare y resulta clave para asegurar la máxima calidad de atención y seguridad clínica del paciente bariátrico.

La evaluación realizada por la OPP también resaltó la obligatoriedad de que las facilidades cuenten con una disponibilidad continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7), de un equipo médico institucional especializado capaz de responder de inmediato a eventos críticos. Destacó que este componente clínico multidisciplinario debe estar integrado por cirujanos bariátricos, intensivistas, especialistas en cuidado crítico, anestesiólogos, nefrólogos y emergenciólogos, complementado con un personal de enfermería debidamente adiestrado tanto para el cuidado ambulatorio como para los pacientes reducidos a cama. Del mismo modo, aseveró que el centro debe poseer instrumentos adaptados y un inventario de equipo rodante idóneo que abarque camas dedicadas, sillas de ruedas, mesas de sala de operaciones, facilidades radiológicas con capacidad para tomografías computarizadas mayores a 350 libras y grúas de levantamiento capaces de soportar más de 450 libras.



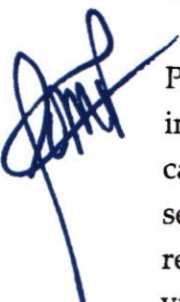
Como medidas de protección operativas adicionales, la OPP considera muy acertado que las instituciones médicas tengan la obligación de contar con un servicio de ambulancia interno o, en su defecto, un contrato formal con una compañía de ambulancias equipada de forma particular para el manejo seguro de la población bariátrica. También sugirió el desarrollo de protocolos escritos minuciosos para el manejo integral de los pacientes, la creación de un comité especial para administrar los criterios de selección del programa, y la provisión obligatoria de servicios de rehabilitación postquirúrgica, grupos de apoyo, planes de seguimiento a largo plazo y educación continua al paciente, cumpliendo además con las exigencias de pago del Plan de Salud Gubernamental. Planteó que el mobiliario motorizado y las grúas de transferencia no solo minimizan los riesgos de lesiones laborales en los profesionales de la salud, sino que garantizan un entorno hospitalario inclusivo, digno y sumamente respetuoso.

La oficina del Procurador del Paciente concluyó que el P. de la C. 707 encamina al sistema de salud hacia una atención médica más humana, moderna y verdaderamente efectiva para la población que sufre de obesidad mórbida y sus complicaciones derivadas. Puntualizó que, al promover un acceso robusto a servicios especializados y fortalecer los principios de equidad, la aprobación de la medida contribuirá directamente a mejorar los resultados clínicos y a elevar de forma notable el bienestar general y la calidad de vida de los puertorriqueños. Agregó, que esta postura es plenamente cónsona con el mandato ministerial de la OPP de velar celosamente porque cada persona tenga un acceso oportuno a servicios de salud de la más alta calidad dentro del territorio de Puerto Rico.

COLEGIO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Examinamos, de igual forma, la ponencia del **Colegio de Profesionales de Enfermería** la suscrito por su Presidenta, Marisel Delgado, en la cual expresó su apoyo a la aprobación de la medida.

Manifestó, como justificación para la aprobación de esta medida la gravedad de la obesidad mórbida, definida técnicamente por un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 35. Resaltó que este padecimiento representa un exceso de grasa severo que pone en riesgo sistémico al paciente, afectando de manera directa sus funciones vitales. Indicó, que entre los peligros médicos asociados se encuentran el desarrollo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y apnea del sueño, además de mermar la expectativa de vida.



Para combatir adecuadamente esta realidad médica, la organización subrayó la importancia de implementar intervenciones clínicas eficaces que vayan más allá de los cambios nutricionales tradicionales y la actividad física. Ilustró, que cuando el paciente se encuentra en niveles de obesidad extrema, resulta sumamente difícil lograr una reducción de peso sostenida por medios convencionales. Añadió que, debido a esto, se vuelve indispensable el acceso oportuno a procedimientos quirúrgicos avanzados como el *bypass* gástrico, la banda ajustable o la gastrectomía en manga.

El Colegio fundamentó que el marco legal actual está regido por la Ley 212-2008, la cual nació con el mandato gubernamental de obligar a las aseguradoras en Puerto Rico a incorporar la cirugía bariátrica en sus pólizas de salud, sujeto a procesos de preautorización médica. Aclaró, que la Ley vigente excluye las cirugías de remoción de exceso de piel, a menos que un médico certifique que dicho tejido sobrante obstruye o afecta de forma severa el funcionamiento de alguna extremidad corporal.

Coincide con lo dispuesto en la exposición de motivos de la pieza legislativa referente a que remover la exigencia de un referido médico primario es un paso imperativo para garantizar la salud del ciudadano. Considera que, al suprimir este trámite, el Gobierno asume su responsabilidad fundamental de facilitar el cuidado médico directo y atemperar el ordenamiento jurídico local a las tendencias científicas internacionales. Afirmó, que esta flexibilización elimina barreras administrativas que históricamente han retrasado la atención especializada de los pacientes en la isla.

Para validar la viabilidad de la reforma, expuso que diversos estados ya han legislado con éxito para conceder acceso directo al bariatra sin preautorizaciones previas. Ilustró que, jurisdicciones como Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Delaware, Ohio, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas sirven como precedentes de que prohibir consultas intermedias innecesarias optimiza el sistema de salud. El Colegio puntualizó que el especialista bariátrico es el único profesional calificado para dictar el tratamiento idóneo, por lo que imponer filtros previos carece de sentido clínico.

Finalmente, el Colegio de Profesionales de la Enfermería reiteró su apoyo al P. de la C. 707 debido a que prioriza la prevención de complicaciones graves y resguarda el bienestar integral de la población. Concluyó, que la medida no debe evaluarse desde un enfoque de costos económicos a corto plazo para las aseguradoras, sino bajo una visión de ahorros sustanciales a largo plazo. Sustentó que, al agilizar el acceso quirúrgico, se mitiga el desarrollo de patologías crónicas secundarias y se frena el deterioro evitable en la calidad de vida de miles de pacientes puertorriqueños.

ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE PUERTO RICO (ACODESE)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE)** quien presentó su memorial explicativo por conducto de su Directora Ejecutiva, la Lcda. Iraelia Pernas. En el mismo, se opuso a la aprobación del Proyecto de la Cámara 707, el cual busca enmendar la Ley 212-2008 sobre la cubierta mandatoria de la cirugía bariátrica y el síndrome metabólico.

Expresó que, si bien reconoce la importancia de que los ciudadanos cuenten con opciones médicas para manejar la obesidad mórbida, las enmiendas propuestas generalizan de manera incorrecta los términos clínicos y expanden la cubierta obligatoria de forma desmedida y preocupante. Alegó que, actualmente, las aseguradoras privadas ya cubren este procedimiento para los casos que cumplen con los estrictos protocolos médicos adoptados por la Ley vigente, por lo que consideran que los cambios propuestos alteran un equilibrio técnico y clínico que ha funcionado de manera segura.

El principal reparo de ACODESE se centra en la propuesta de ampliar de forma significativa la definición de obesidad mórbida mediante la inclusión del concepto de comorbilidad. Sostuvo, que la legislación actual restringe el acceso al tratamiento quirúrgico basándose en un parámetro objetivo, que es tener un Índice de Masa Corporal

igual o mayor a 35. Sin embargo, denunció que el Proyecto estipula que si un paciente padece de alguna co-morbilidad que aumente la severidad o las complicaciones de salud, será considerado automáticamente como un paciente elegible para cirugía bariátrica, independientemente de su masa corporal o su índice de masa corporal, lo que abre las puertas del quirófano a una población masiva sin un criterio de peso claro.

ACODESE advirtió que la definición propuesta para el término co-morbilidad es sumamente amplia y adolece de una vaguedad jurídica peligrosa, ya que abarca una lista extensa de condiciones como la hipertensión, el asma, el reflujo gastroesofágico y la apnea del sueño, dejando además la lista abierta a cualquier otra enfermedad. Es de la opinión que, al no establecer parámetros objetivos sobre la severidad, el nivel de control o la relación causal directa entre la condición secundaria y la obesidad, la Ley se prestaría a interpretaciones erróneas. Señaló que, bajo esta redacción, una persona diabética con un índice de masa corporal de 30 cualificaría de forma automática para una cirugía bariátrica, lo que desvirtúa el propósito original de la legislación que es tratar la obesidad mórbida extrema.

La oposición de ACODESE a la aprobación de la pieza legislativa también se fundamenta en que incurre en contradicciones con la propia literatura médica que cita como base, específicamente con la Declaración Conjunta 2022 de la ASMBS y la IFSO. Argumentó que, mientras que la medida cataloga como discriminatoria la práctica de exigir un periodo de pérdida de peso no quirúrgico antes de la operación, los estudios científicos citados recomiendan de manera consistente que se intente una terapia no quirúrgica previa antes de considerar el tratamiento quirúrgico invasivo. Agregó, que la literatura médica internacional sostiene que los tratamientos médicos de pérdida de peso tienen una gran efectividad y durabilidad en pacientes con un índice de masa corporal menor a 35, por lo que reiteró que la cirugía debe ser la última opción y no la primera.

Otra gran preocupación para el sector de los seguros es que el Proyecto no se encuentra acompañado de un análisis actuarial que permita cuantificar el impacto económico real de las nuevas obligaciones impuestas. Advirtió, que la expansión de la población elegible para la cirugía bariátrica e intervenciones adicionales incrementará inevitablemente la utilización de estos costosos servicios médicos y los gastos asociados a su prestación. Alertó, que este aumento drástico en los costos operacionales se verá reflejado de manera directa en un incremento en las primas mensuales de todos los asegurados, afectando la

sostenibilidad de los productos de seguro y disminuyendo la asequibilidad de las cubiertas de salud para los consumidores en la Isla.

Asimismo, denunció un trato regulatorio desigual e injustificado entre el mercado de los planes médicos privados y el Plan de Salud del Gobierno, conocido como Plan Vital. Indicó que el Proyecto impone de forma obligatoria a los planes privados la cobertura del procedimiento de balón intragástrico aprobado por la FDA, pero deja abierta la posibilidad de que no esté cubierto bajo el Plan Vital al condicionarlo a los requisitos del Programa Medicaid federal. Para ACODESE, resulta irrazonable establecer cargas exclusivas para el sector comercial sin una justificación técnica o clínica clara, ya que un procedimiento médico no debería ser mandatorio para un sector y opcional para el otro si el impacto financiero y de salud es el mismo.



Planteó que, en la misma línea de expansión desmedida, se elimina la obligación de cubrir "al menos uno de los tipos de cirugía bariátrica", forzando ahora a los aseguradores a cubrir de manera abierta todos los tipos de procedimientos disponibles. De igual forma, alertó que la enmienda elimina la facultad legal que poseían las compañías de seguros de salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) para requerir a los afiliados un periodo de espera de hasta doce meses antes de autorizar el beneficio. ACODESE considera que este periodo de espera es fundamental para la preparación del paciente y para evaluar su compromiso real con los cambios nutricionales necesarios.

Señaló, además, que la medida legislativa también pretende forzar la cobertura de procedimientos revisionales, intervenciones endoscópicas y terapias farmacológicas relacionadas con complicaciones de la operación primaria. Aclaró, que los planes médicos actuales ya cubren los medicamentos postquirúrgicos esenciales, tales como: multivitaminas, protectores estomacales, anticoagulantes y tratamientos para prevenir piedras en la vesícula biliar durante la pérdida rápida de peso. La preocupación de ACODESE estriba en que la redacción del Proyecto es tan amplia y ambigua que podría obligar a los aseguradores a cubrir costosos medicamentos para la pérdida de peso, como los de tipo GLP-1 (Ozempic o Mounjaro), bajo el pretexto de potenciar los resultados de la cirugía.

De otra parte, enfatizó que las terapias farmacológicas obligatorias deben estar basadas estrictamente en las indicaciones establecidas por los fabricantes y aprobadas por la FDA. Es de la opinión que, permitir que la Ley obligue a cubrir cualquier fármaco para

promover la pérdida de peso postoperatoria sin delimitar criterios objetivos ni guías clínicas aplicables representa un riesgo financiero extremo y descontrolado para el sistema de salud. Para la ACODESE, la medida debe delimitar con precisión qué terapias farmacológicas quedarían comprendidas dentro de la cubierta en lugar de dejar un vacío legal que preste a la libre interpretación de los proveedores médicos.

Con respecto al argumento de que mantener un periodo de espera pone en riesgo la vida de los pacientes, aclaró que la Ley 212-2008 vigente ya resuelve este problema de manera compasiva y segura. Sostuvo, que legislación actual provee mecanismos claros para eximir al paciente del periodo de espera de doce meses cuando el médico especialista certifica que la vida de la persona se encuentra en un riesgo inminente. Sobre esto, argumentó que eliminar por completo el periodo de espera para todos los casos generales es una decisión desacertada que solo incentiva la falta de preparación y adaptación del paciente antes de someterse a una intervención mayor.

Finalmente, ACODESE enfatizó que la cirugía bariátrica no constituye una solución mágica para el problema de la obesidad. Añadió que, al tratarse de una intervención quirúrgica invasiva, conlleva riesgos significativos que pueden representar un peligro mayor en pacientes que padecen de condiciones crónicas preexistentes como diabetes, complicaciones cardiovasculares o hipertensión arterial. Puntualizó, que el legislador original de la Ley 212-2008 reconoció estos peligros y por ello incluyó requisitos específicos y filtros clínicos que el candidato debe cumplir para demostrar una voluntad real de adherirse al tratamiento y de modificar permanentemente sus patrones de alimentación.

ACODESE reiteró su total oposición al Proyecto de la Cámara 707 al entender que una medida de esta envergadura requiere un análisis mucho más responsable y exhaustivo de la literatura médica completa, en lugar de adoptar enmiendas apresuradas que afectarán el acceso general de la población a sus seguros de salud privados debido al encarecimiento del mercado.

MCS ADVANTAGE, INC.

Tras haber cursado una solicitud de memorial Explicativo a **MCS Advantage, Inc.**, esta Ilustre Comisión recibió una comunicación suscrita por su Presidente, Roberto ZG. Pando Cintrón, donde indica que la posición de su empresa fue compartida en el memorial que sometió ACODESE sobre la medida. Por lo que se suscriben a sus comentarios.

MMM HOLDINGS, LLC.

Recibimos, de igual forma, los comentarios de **MMM Holdings, LLC.** por conducto de su Director Senior, Jonathan A. Bonet Rivera donde detallaron ciertas recomendaciones a ser consideradas dentro del proceso de evaluación de la medida.

En términos generales, la aseguradora reconoció el propósito meritorio del Proyecto al intentar modernizar el marco legal de unas condiciones crónicas que exigen un manejo interdisciplinario y un acceso oportuno. Asimismo, coincide plenamente con la urgencia de actualizar e incorporar definiciones formales, tales como las de obesidad mórbida, cirugía metabólica y co-morbilidad, para alinearlas con la evidencia científica actual y respalda la armonización de estos parámetros con los requisitos del Programa Medicaid y el modelo de cuidado coordinado que impera en la Isla.



No obstante, a pesar de validar las intenciones de la pieza legislativa, enfatizó que el texto final debe integrar salvaguardas operacionales claras para garantizar una implantación ordenada y fiscalmente sostenible. Como medida de control clínico y financiero, MMM favoreció el que se retenga el requisito de preautorización para los procedimientos. Planteó, que este proceso debe estar fundamentado en un plan de tratamiento detallado y estructurado por el especialista bariátrico, el cual debe documentar de forma rigurosa los beneficios esperados, las evaluaciones nutricionales previas y los riesgos de salud inminentes que justifican la cirugía.

Con el objetivo de reducir la disparidad de criterios en las evaluaciones médicas, la recomendó que el Departamento de Salud diseñe un flujograma administrativo uniforme. Sostuvo, que esta reglamentación oficial definiría con exactitud la documentación requerida para activar las cubiertas, promoviendo consistencia entre todas las aseguradoras y los proveedores de servicios médicos, así como proveería mayor certeza legal y operacional tanto a los pacientes que solicitan el servicio como a las instituciones encargadas de su aprobación y facturación.

Respecto a los términos de acceso al beneficio, MMM considera prudente establecer un periodo de espera no mayor de doce meses antes de que un afiliado pueda ser elegible para la intervención. Señaló, que esta restricción temporal solo admitiría excepciones justificadas bajo una necesidad médica expedita o un peligro inminente para la vida del paciente debidamente certificado. Como complemento indispensable para asegurar el éxito clínico de la cirugía a largo plazo, propuso que el paciente se comprometa a

participar activamente en un programa postoperatorio de manejo de la obesidad por un año adicional.

Otra recomendación presentada por MMM es la clarificación explícita del alcance del Proyecto dentro de los distintos mercados de seguros. Advirtió, que si la intención legislativa incluye impactar el sector público, específicamente el Plan Vital, es obligatorio realizar una evaluación fiscal en conjunto con ASES y el Departamento de Salud, mientras, que si el estatuto está destinado únicamente al mercado comercial privado, el lenguaje legal debe expresarlo con absoluta precisión para evitar conflictos de interpretación contractual y lagunas regulatorias futuras.



Argumentó que el programa federal Medicare Advantage debe ser excluido formalmente del alcance de esta Ley debido a que opera bajo una jurisdicción exclusiva del gobierno federal y CMS, diferenciándose sustancialmente de los modelos duales o compartidos como el Plan Vital. MMM ilustró con la jurisprudencia federal reciente y las cláusulas de campo ocupado el impedimento de que las regulaciones del Gobierno de Puerto Rico interfieran con los estándares de beneficios contratados a nivel federal.

Para concluir, reafirmó su compromiso con la alta calidad clínica y ofreció su disposición para colaborar activamente con la Asamblea Legislativa en la redacción final de la medida. Puntualizó, que el fin último es lograr un balance que adelante el acceso a la salud para la obesidad metabólica sin desestabilizar la sostenibilidad operacional de los programas médicos en Puerto Rico.

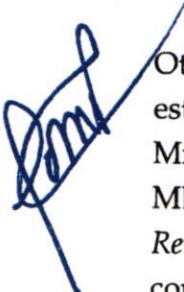
ASMBS ACCESS TO CARE REPRESENTATIVE- PUERTO RICO

Esta Ilustre Comisión recibió los comentarios remitidos por **ASMBS Access to Care Representative- Puerto Rico**, a través del Dr. Javier Birriel, quien, a su vez, es cirujano metabólico y bariátrico expresándose a favor de la aprobación de la medida con recomendaciones al texto para fortalecer la claridad clínica del Proyecto, expandir el acceso de los pacientes a los tratamientos, uniformar las cubiertas médicas y blindar la Ley ante interpretaciones administrativas restrictivas de los aseguradores.

En términos generales, expresó su total coincidencia y respaldo a los objetivos centrales del P. de la C. 707, reconociendo la necesidad apremiante de modernizar una legislación que data del año 2008. Destacó positivamente que la medida incorpore los conceptos y guías clínicas internacionales de la ASMBS/IFSO de 2022, procure limitar las barreras de

preautorización impuestas por las aseguradoras y busque establecer criterios uniformes de cubierta. Resaltó que las recomendaciones presentadas no pretenden alterar estos fines, sino volverlos ejecutables y claros.

Planteó la necesidad de eliminar barreras burocráticas y requisitos de preautorización que carecen de base científica. Argumentó, además, que las aseguradoras suelen imponer trabas como programas obligatorios de pérdida de peso no quirúrgicos, dietas supervisadas y períodos de espera arbitrarios que solo retrasan la atención médica y menoscaban el juicio clínico del equipo tratante. Enfatizó, que los pacientes con un Índice de Masa Corporal (IMC) alto no deberían verse obligados a demostrar fracasos previos en tratamientos no quirúrgicos para obtener su cubierta.



Otro punto crucial abordado en el memorial presentado por ASMBS fueron los estándares de acreditación de las instalaciones de salud donde se realizan estas cirugías. Mientras que el Proyecto original de la Cámara exige exclusivamente la certificación MBSAQIP, este sugirió ampliar el reconocimiento a la acreditación que otorga la *Surgical Review Corporation* (SRC). Argumentó que el monopolio legal a una entidad privada es contraproducente y que se debe habilitar un mecanismo para que el Departamento de Salud valide a futuros acreditadores bajo criterios de equivalencia sustancial.

De igual forma, expuso la necesidad de establecer una vía provisional y regulada para nuevos programas bariátricos en la Isla. Advirtió sobre el peligro de crear una barrera circular: los centros nuevos necesitan realizar cirugías para alcanzar el volumen mínimo exigido para acreditarse, pero no podrían operar si se les exige la acreditación final desde el primer día. Por ello, propuso una estructura de cumplimiento temporal que garantice la cubierta y pago por parte de los planes médicos mientras los centros completan su proceso formal de acreditación.

Subrayó la importancia de actualizar las definiciones técnicas y la terminología legal del Proyecto, aconsejando descartar expresiones cerradas como "procedimientos aprobados por la FDA" (debido a que la FDA aprueba dispositivos o fármacos, no operaciones en sí) y sustituirlas por definiciones basadas en guías nacionales vigentes.

A continuación, se enumeran los planteamientos de las recomendaciones técnicas sugeridas por ASMBS:

- 
1. Exención de programas previos de pérdida de peso: Planteó aclarar explícitamente que los pacientes con un IMC ≥ 35 kg/m² no tienen la obligación de evidenciar un fracaso previo en programas obligatorios o regímenes de pérdida de peso no quirúrgicos para ser elegibles para la cirugía.
 2. Prohibición directa de barreras automáticas: Propuso vetar de forma tajante que las aseguradoras impongan dietas supervisadas obligatorias, requisitos preoperatorios de porcentaje fijo de pérdida de peso, períodos arbitrarios de espera o un número predeterminado de visitas médicas no individualizadas.
 3. Definición de "requisitos uniformes": Pretende delimitar por Ley este alcance para obligar a los planes médicos privados a adoptar los criterios clínicos de la legislación como mínimos vinculantes, impidiendo que apliquen políticas internas que resulten más restrictivas.
 4. Preservación del juicio clínico y transparencia: Recomendó resguardar la autonomía del equipo médico tratante para definir los estudios, optimizaciones y consultas preoperatorias necesarias de cada paciente. Asimismo, exigir que las aseguradoras detallen con total transparencia la base científica en sus denegaciones por necesidad médica.
 5. Reconocimiento multisectorial de acreditaciones: Planteó expandir las certificaciones institucionales válidas aceptando tanto el programa MBSAQIP como el *SRC Center of Excellence*, permitiendo además que el Departamento de Salud homologue en el futuro a otros organismos evaluadores con base en criterios objetivos.
 6. Creación de una vía provisional para nuevos centros: Sugirió abrir una ventana regulada y supervisada de hasta 36 meses para que los nuevos programas bariátricos puedan desarrollar el volumen de casos requerido para su acreditación, gozando de protección expresa de cubierta y pago hospitalario durante este periodo interino.
 7. Separación de acreditación y credencialización: Propuso desvincular la certificación física del hospital de los privilegios particulares del cirujano, exigiendo a los profesionales requisitos específicos de formación en cirugía

general, especialización o *fellowship*, volumen de experiencia documentada y procesos de mentoría o *proctoring* si fuese necesario.

- 
8. Modernización en la definición de procedimientos: Sugirió no amarrar la Ley a una lista estática ni al uso de términos técnicamente imprecisos como "aprobado por la FDA". En su lugar, recomendó definir la cirugía bariátrica bajo los estándares y el aval continuo de las organizaciones profesionales de la salud.
 9. Reformulación de la cubierta para cirugía revisional: Planteó que el acceso a una cirugía de revisión, conversión o reversión dependa estrictamente de la necesidad médica documentada (como complicaciones o respuesta clínica insuficiente), eliminando la exigencia arbitraria de calificar el escenario como una "circunstancia excepcional".
 10. Evaluación psicosocial individualizada: Recomendó garantizar que el protocolo de evaluación psicológica o psiquiátrica responda a las necesidades individuales del paciente evaluado por el equipo multidisciplinario, prohibiendo que los pagadores lo conviertan en un número de visitas o sesiones obligatorias genéricas.
 11. Acceso directo al especialista sin referidos: Sugirió incorporar a la parte dispositiva de la Ley el derecho del paciente a acudir directamente a evaluaciones con médicos especialistas en obesidad o cirujanos bariátricos, sin que se requiera obligatoriamente un referido del médico primario.
 12. Inclusión de una cláusula antielusión: Propuso añadir un mecanismo legal expreso que impida que los manuales de utilización, contratos con terceros administradores, pólizas o políticas médicas internas de los aseguradores rebajen o anulen las cubiertas y protecciones dispuestas por la Ley.
 13. Modernización de la terminología de obesidad: Aconsejó que la técnica legislativa se actualice reemplazando el uso generalizado del término "obesidad mórbida" por conceptos modernos y contemporáneos como "obesidad", "obesidad severa" o "enfermedad metabólica", facilitando la consistencia con las nuevas guías clínicas.

ASMBS concluyó reiterando que la legislación será más duradera si fija los derechos fundamentales de acceso en el estatuto, permitiendo que las especificaciones técnicas y los volúmenes quirúrgicos evolucionen mediante la vía reglamentaria.

AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY (ASMBS)

La American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) expresó su apoyo condicionado a la aprobación del P. de la C. 707, el cual busca enmendar la Ley Núm. 212-2008 sobre la cobertura de cirugía bariátrica en Puerto Rico. Mediante su Presidente, Dr. Joe Northup, reconoció el esfuerzo de la Cámara de Representantes y del representante Méndez Núñez por modernizar este marco legal. Sostuvo, que el objetivo principal es alinear la legislación local con las indicaciones clínicas globales emitidas en 2022 por la ASMBS y la IFSO, las cuales cuentan con el respaldo de más de 50 sociedades profesionales a nivel mundial.

ASMBS identificó como positivo que el proyecto reconozca explícitamente a la obesidad como una enfermedad crónica que requiere un manejo continuo en lugar de una intervención única. Asimismo, ponderó la expansión de los criterios de elegibilidad basados en evidencia científica actualizada, la eliminación de barreras burocráticas innecesarias entre pacientes y especialistas, y la obligatoriedad de que las instalaciones médicas cuenten con una acreditación específica para procedimientos bariátricos.

A pesar de respaldar los objetivos fundamentales de la medida, enfatizó la necesidad de fortalecer y aclarar la redacción del texto legislativo. La ASMBS advirtió que la existencia de un lenguaje ambiguo representa un riesgo severo, ya que las aseguradoras privadas podrían interpretarlo de manera restrictiva. Esto terminaría recreando u originando de forma indirecta las mismas barreras de acceso a la salud que el proyecto de ley pretende erradicar de forma definitiva.

Por esta razón, la organización presentó una serie de enmiendas técnicas detalladas diseñadas para evitar la evasión de las protecciones por parte de los planes médicos a través de manuales de utilización, contratos o políticas internas. Entre los puntos críticos señalados se encuentran la flexibilización de los umbrales del Índice de Masa Corporal (IMC) según el origen étnico, la prohibición sustancial de dietas supervisadas obligatorias preoperatorias y la sustitución del estándar de "circunstancias excepcionales" por el criterio único de necesidad médica para segundas intervenciones.

En específico las recomendaciones presentadas por ASMBS son:

- Clarificar la elegibilidad de manera consistente con las indicaciones de la ASMBS/IFSO de 2022. Considera que la referencia del Artículo 3(c) a un tratamiento previo "fallido" podría interpretarse como un requisito para que los pacientes con un IMC ≥ 35 kg/m² documenten un tratamiento no quirúrgico fallido

antes de que la cirugía se considere médicamente necesaria, lo cual es inconsistente con las guías actuales que no imponen tal umbral para ese IMC. Planteó que la elegibilidad también deberá extenderse a pacientes con diabetes tipo 2 e IMC ≥ 30 kg/m², y a pacientes con IMC de 30 a 34.9 kg/m² que no hayan logrado una mejora duradera a través de métodos no quirúrgicos, en consistencia con el juicio clínico individualizado en lugar de una lista estatutaria fija. Propuso ajustar los umbrales de IMC en la población asiática, de modo que un IMC de 25 kg/m² sugiera obesidad clínica y a los individuos con un IMC de 27.5 kg/m² se les deba ofrecer cirugía metabólica y bariátrica.

- 
- Prohibir las barreras administrativas por su sustancia, no por su etiqueta. Alertó que aunque el Proyecto prohíbe las consultas requeridas por la aseguradora más allá de lo que recomiende el especialista, las aseguradoras pueden lograr el mismo retraso a través de otros mecanismos: periodos obligatorios de dieta supervisada, porcentajes fijos de pérdida de peso preoperatoria, periodos de espera arbitrarios o un número fijo de visitas no relacionadas con la necesidad clínica individual. Por eso propuso que la prohibición debe alcanzar la sustancia de estos requisitos, independientemente de cómo se les llame.
 - Definir "requisitos uniformes". Sostuvo, que, tal como está redactado, una aseguradora podría satisfacer la "uniformidad" simplemente aplicando sus propios criterios, potencialmente más restrictivos, de manera consistente. A tales fines, sugirió establecer que los criterios mínimos de elegibilidad clínica y que ninguna aseguradora puede imponer criterios más estrictos mediante contratos, políticas médicas o manuales de utilización.
 - Afirmar el MBSAQIP como el estándar de acreditación. Indicó que el requisito del Proyecto de obtener una acreditación a través del Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad de la Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP), el programa conjunto de ACS/ASMBS, es el estándar correcto, y apoyamos su inclusión tal como está redactado. A tales fines, recomendó que la Comisión considere también una disposición de transición razonable para los centros quirúrgicos que se encuentren trabajando activamente hacia la acreditación del MBSAQIP, de modo que no se les niegue el acceso a la atención a los pacientes durante el proceso de acreditación de un centro, siempre que este demuestre un

progreso documentado y de buena fe hacia la acreditación dentro de un plazo definido.

- 
- Separar la acreditación de la instalación de las credenciales del cirujano. Agregó, que el Proyecto aborda dónde se realiza la cirugía, pero no quién está calificado para realizarla. Ante esto, sugirió criterios estatutarios de acreditación específicos para bariatría: residencia en cirugía general, certificación o elegibilidad de la junta (board), capacitación o experiencia bariátrica documentada y competencia específica en el procedimiento, distintos de los privilegios quirúrgicos generales.
 - Reemplazar "circunstancias excepcionales" por necesidad médica. Expuso, que el estándar del Proyecto para autorizar un segundo procedimiento bariátrico introduce un umbral no definido que va más allá de la necesidad médica. Dado que la obesidad es una enfermedad crónica, considera que los procedimientos de revisión y seguimiento deben regirse únicamente por la necesidad médica documentada, sin una barrera adicional no definida o un límite de por vida.
 - Añadir una cláusula estricta contra la evasión (anti-circumvention clause). Señaló que, sin ella, las protecciones de esta Ley pueden reintroducirse por contrato, a través de políticas médicas, manuales de utilización o acuerdos con administradores de terceros (TPA). Recalcó que resulta necesaria una disposición expresa que impida esto para que las demás reformas sean aplicables en la práctica.
 - Confirmar que no se requiere un referido de un médico de cabecera (atención primaria) para que un paciente sea evaluado por un médico especialista en medicina de la obesidad o un cirujano metabólico y bariátrico, una intención que ya se expresa en la Declaración de Propósito del Proyecto, pero advirtió que aún no se refleja en el texto estatutario operativo.
 - Definición del procedimiento. Indicó que la referencia del Proyecto a otros "procedimientos quirúrgicos aprobados por la FDA" es técnicamente imprecisa, ya que la FDA generalmente regula medicamentos y dispositivos en lugar de aprobar operaciones quirúrgicas. Recomendó que la definición del procedimiento haga referencia a los procedimientos reconocidos bajo los estándares profesionales

nacionales vigentes, de modo que el estatuto no dependa de una lista congelada o imprecisa.

- Transparencia en las denegaciones por necesidad médica. Enfatizó que cualquier determinación adversa debe identificar el criterio clínico específico en el que se fundamentó, y cualquier revisión de colega a colega (*peer-to-peer*) debe ser realizada por un médico con capacitación y experiencia relevante en cirugía metabólica y bariátrica.
- Evaluación psicosocial individualizada. Señaló, además, que la referencia del Proyecto a un "protocolo psicológico" no debe permitir que las aseguradoras impongan un número fijo y no individualizado de visitas requeridas como condición para la autorización.



ASMBS concluyó reiterando que el P. de la C. 707 atiende una necesidad legítima que ha estado postergada por mucho tiempo en beneficio de los pacientes puertorriqueños e instó a la Comisión de Salud del Senado a incorporar la totalidad de estas modificaciones técnicas en el texto operativo de la ley y se puso su disposición para ofrecer testimonios o más información clínica que facilite su aprobación favorable.

CENTRO MÉDICO EPISCOPAL SAN LUCAS

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el **Centro Médico Episcopal San Lucas**, presentó su memorial explicativo ante la Cámara de Representantes, suscrito por su Director Ejecutivo Operacional, el Lcdo. Rafael Alvarado Noriega, expresándose su apoyo a la aprobación de la medida.

Fundamentó su respaldo en la necesidad imperativa de modernizar el marco legal aplicable al tratamiento quirúrgico de esta condición en Puerto Rico. Específicamente, el destacó como aciertos principales de la medida la estandarización de los requisitos de cobertura médica, la revisión de los periodos de elegibilidad y la devolución de la autoridad clínica al especialista bariátrico.

La postura institucional del hospital surge como una respuesta directa a la marcada variabilidad y disparidad de criterios que actualmente aplican las distintas aseguradoras de salud en la Isla. Según expuso, las diferencias arbitrarias en cuanto a los criterios de

elegibilidad, los requisitos preoperatorios y los periodos de espera impuestos por los planes médicos generan graves inequidades en el acceso a la salud. Señaló, que estas discrepancias puramente administrativas provocan demoras perjudiciales e injustificadas en el tratamiento de la obesidad, la cual ya es ampliamente reconocida como una enfermedad crónica por las principales organizaciones e instituciones internacionales de salud.

 Para corregir esta problemática, el Centro Médico Episcopal San Lucas respalda la adopción de las guías clínicas conjuntas del 2022 publicadas por la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS) y la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO). Es de la opinión, que estas directrices internacionales establecen criterios uniformes basados estrictamente en evidencia científica y no en conveniencias financieras. Planteó que, al alinearse con estas guías, el Proyecto asegura que la evaluación y la determinación de los exámenes médicos preoperatorios sean responsabilidad exclusiva del especialista en cirugía o medicina bariátrica, garantizando que las decisiones terapéuticas se centren en las necesidades reales del paciente y no en las limitaciones de las aseguradoras.

Asimismo, favoreció la eliminación de los periodos de espera prolongados que se le imponen a los pacientes tras someterse a intervenciones dietéticas previas como requisito para cualificar para la cirugía. El hospital argumentó, que no existe ningún tipo de evidencia científica que respalde la práctica de dilatar el acceso quirúrgico mediante tratamientos paliativos de pérdida de peso que han demostrado ser insuficientes para la obesidad mórbida. Por lo tanto, considera que remover estas trabas temporales representa un paso crucial para erradicar retrasos burocráticos y optimizar una atención médica que debe ser oportuna para evitar el deterioro de la salud general del individuo.

Finalmente, el Centro Médico Episcopal San Lucas enfatizó su autoridad en la materia al recordar que es una facilidad debidamente acreditada bajo los rigurosos estándares del Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad de la Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP). A través de este aval de calidad, la institución hospitalaria reafirmó su compromiso inquebrantable con la adopción de las mejores prácticas médicas basadas en la evidencia.

Concluyó que el P. de la C. 707 es un instrumento vital para armonizar la política pública de Puerto Rico con los avances de la ciencia moderna, asegurando un acceso equitativo, seguro y de alta calidad para toda la población que padece esta condición.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Salud certifica que el P. de la C. 707 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES



El Proyecto de la Cámara 707 representa un esfuerzo legislativo para actualizar el marco normativo del tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico en Puerto Rico, sustituyendo disposiciones que han quedado científicamente rezagadas tras más de quince años de vigencia de la Ley Núm. 212-2008. Tras analizar los comentarios presentados por las Agencias y entidades consultados, surge un consenso mayoritario sobre la necesidad de atemperar el acceso a la salud a los postulados de la Declaración Conjunta de 2022 de la ASMBS y la IFSO.

Como posiciones afines o similares que respaldan la aprobación del Proyecto, se destacan tanto el Departamento de Salud como la ASES, quienes confirieron su endoso luego de que la Cámara de Representantes acogiera sus enmiendas enfocadas en proteger la sostenibilidad fiscal del Plan de Salud Gubernamental, permitiendo que el Programa Medicaid y ASES mantengan la potestad de establecer requisitos distintos de cubierta y limitar la cirugía bariátrica a casos de estricta necesidad médica. En esta misma línea de apoyo y de protección de los derechos de los ciudadanos, la Oficina del Comisionado de Seguros y la Oficina del Procurador del Paciente coincidieron en que incorporar formalmente el concepto de "co-morbilidad" y eliminar la exigencia de referidos del médico primario para acceder al especialista son pasos indispensables para agilizar la atención y aliviar cargas burocráticas redundantes.

El Colegio de Profesionales de Enfermería, también expresó su apoyo argumentando que las intervenciones quirúrgicas avanzadas son la única opción efectiva cuando los métodos convencionales fallan en niveles de obesidad extrema, mientras que el Centro Médico Episcopal San Lucas y los líderes de la ASMBS validaron clínicamente la medida, enfatizando que la legislación devuelve la autonomía al médico especialista y eleva los

estándares de seguridad mediante la acreditación obligatoria bajo el programa MBSAQIP.

Por el contrario, el sector de las aseguradoras privadas articuló una postura marcadamente opuesta y de preocupación. ACODESE se opuso a la aprobación de la medida argumentando que expandir la definición de obesidad mórbida mediante el concepto de co-morbilidad flexibiliza los criterios de forma desmedida, permitiendo que pacientes con un Índice de Masa Corporal menor al estándar actual cualifiquen de forma automática y masiva para cirugías invasivas. ACODESE alertó, además, sobre el riesgo financiero de verse obligados a cubrir costosas terapias farmacológicas complementarias (como los medicamentos GLP-1) sin un análisis actuarial previo, lo que inevitablemente encarecerá el mercado y provocará un alza en las primas mensuales de todos los asegurados privados en la Isla, generando además un trato desigual frente al sector público. Por su parte, MMM Holdings presentó un apoyo condicionado, sugiriendo un enfoque que mantenga las preautorizaciones basadas en planes estructurados, preserve un periodo de espera razonable para evaluar el compromiso del paciente y excluya explícitamente al programa federal Medicare Advantage por motivos de jurisdicción exclusiva.

A pesar de estas posturas divergentes, la aprobación de la medida se justifica de manera contundente por los amplios beneficios de salud y socioeconómicos que traerá a Puerto Rico a largo plazo. En primer lugar, el Proyecto salva vidas al reconocer la obesidad como una enfermedad crónica sistémica que requiere un manejo vitalicio y no paliativo, adaptando las leyes locales a los descubrimientos de la ciencia médica moderna que confirman que la cirugía metabólica es el tratamiento más eficaz basado en evidencia. Al suprimir los tiempos de espera arbitrarios y los filtros administrativos que carecen de base científica, la legislación garantiza que miles de pacientes que sufren complicaciones graves tengan un acceso directo, equitativo y humano a los especialistas idóneos antes de que su condición ponga en riesgo inminente su vida.

Es importante destacar que, al mitigar de forma temprana la obesidad mórbida, se frena de raíz el desarrollo y deterioro de patologías secundarias crónicas de altísimo costo operacional para las aseguradoras y el Estado, tales como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño e insuficiencia cardíaca. Esto se traducirá en ahorros sustanciales y sostenibles en el gasto futuro de medicamentos vitalicios, visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones prolongadas. Además, la

obligatoriedad de que estos procedimientos se efectúen en centros que cumplan con la acreditación MBSAQIP dota a la Isla de una infraestructura hospitalaria robusta, con equipos especializados e inclusivos y un personal multidisciplinario 24/7, garantizando los más altos estándares de calidad, dignidad y seguridad clínica para el paciente bariátrico puertorriqueño.

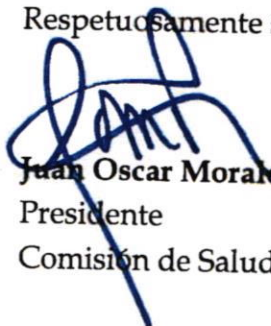
Luego de realizar un análisis exhaustivo de la pieza legislativa y analizar los argumentos y comentarios esbozados, se pudieron identificar algunos cambios que corresponden para lograr una mejor implementación de la medida. Es por esto, que la Comisión de Salud implementó los siguientes cambios o sugerencias:

- 
- Se eliminó de la Exposición de Motivos la referencia a la exclusión del referido médico.
 - Se uniformó el uso del término "Plan de Salud Gubernamental", toda vez que también se utilizaba la variante "Plan de Salud del Gobierno".
 - Se incluyó en el Artículo 3(c) la referencia a que el paciente "ha fallado en los métodos no quirúrgicos".
 - Se estableció específicamente que no se podrán establecer criterios clínicos adicionales o más restrictivos que aquellos permitidos por la Ley como condición para autorizar una cirugía metabólica o bariátrica.
 - Se incluyó la prohibición de adoptar, mediante póliza, contrato, política médica, manual de utilización u otro instrumento, criterios clínicos de elegibilidad más restrictivos que los establecidos en la Ley. No obstante, se aclaró que, si se podrán establecer requisitos administrativos razonables dirigidos a documentar el cumplimiento con los criterios, siempre que dichos requisitos no creen condiciones clínicas adicionales, modifiquen los criterios de elegibilidad ni provoquen retrasos irrazonables en el tratamiento.
 - Se estableció que toda determinación adversa basada en necesidad médica deberá identificar específicamente el criterio clínico utilizado, la información clínica que sustenta la determinación y la razón por la cual el servicio solicitado no cumple con dicho criterio
 - Se realizaron enmiendas técnicas.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, **RECOMENDANDO LA APROBACIÓN** del **Proyecto de la Cámara 707** con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(22 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 707

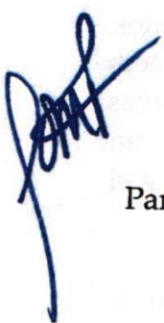
6 DE JUNIO DE 2025

Presentado por el representante Méndez Núñez

(Por petición de la *Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica ASMBS – Capítulo de Puerto Rico* y del *Grupo de Pacientes Bariátricos un Nuevo Amanecer*)

Referido a las Comisiones de Salud; y de Hacienda

LEY



Para enmendar los Artículos 1, 2, y 3 de la Ley Núm. 212-2008, a los fines de añadir la definición de "co-morbilidad"; atemperar las disposiciones de la Ley 212-2008 a la Declaración Conjunta 2022 de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica ("ASMBS" por sus siglas en inglés) y Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos ("IFSO" por sus siglas en inglés) relacionadas con las recomendaciones clínicas y cubierta de beneficios para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica según se establece en dicha legislación, que no sean incompatibles con los parámetros establecidos por el gobierno federal para el Programa Medicaid; establecer que las pólizas de seguros cobijadas al amparo de esta Ley tendrán requisitos uniformes; prohibir que las organizaciones de seguros de salud o demás entidades mencionadas en esta Ley impongan consultas previas con profesionales de la salud que no sean los recomendados por el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica al momento de solicitar dicha preautorización, como pre-requisito para brindar al paciente asegurado la preautorización establecida al amparo de esta Ley; establecer que el médico especialista en

medicina bariátrica o en cirugía bariátrica determinará aquellos exámenes médicos que serán necesarios realizarse a cada paciente por individual antes de realizarse la cirugía bariátrica recomendada, en adición con la preparación quirúrgica necesaria para que el paciente mejore su co-morbilidad y los problemas encontrados bajo los cuales no lograron su cometido que llevan a la recomendación del procedimiento de cirugía bariátrica a utilizarse con dicho paciente; establecer que la instalación de salud en que se realizará la cirugía bariátrica debe contar con la acreditación del Programa Conjunto conocido como el Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP, por sus siglas en inglés), el cual es una iniciativa conjunta de acreditación establecida por la American College of Surgeons (A.C.S.) y la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (A.S.M.B.S.) dedicadas específicamente en acreditar centros con programas de cirugía bariátrica; autorizar al Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, al Comisionado de Seguros y a la Administración de Seguros de Salud a aprobar la reglamentación necesaria para llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley; y para otros fines relacionados.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad ineludible de garantizar el acceso a los servicios de salud y velar por el ofrecimiento eficiente de los mismos. Cónsono con la política pública de procurar servicios de salud ágiles, accesibles y eficaces a los puertorriqueños, es necesario el atemperar la legislación existente a las nuevas tendencias científicas relacionadas con las recomendaciones clínicas para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica.

A tales efectos, para el año 2008, se aprobó la Ley 212, la cual requiere que se establezca como mandatorio en todo ofrecimiento de contrato de seguros de salud, sea privado o gubernamental, que se incluya dentro de su póliza el pago de la cubierta de servicios clínicos, para el tratamiento de la obesidad mórbida y el síndrome metabólico con la cirugía bariátrica, siempre y cuando un médico y hospital especializado en medicina bariátrica y/o cirugía bariátrica lo estipule necesario, así como para el pago de los procedimientos, diagnósticos, tratamientos y medicamentos posteriores a la cirugía. Ya han transcurrido más de quince (15) años desde su establecimiento, y la misma no ha sido revisada ni atemperada a las nuevas tendencias científicas relacionadas con el tratamiento de la condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico.

Un ejemplo de esto es el siguiente: para el año 2022, los líderes de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica ("ASMBS" por sus siglas en inglés) y de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos ("IFSO" por sus siglas en inglés) firmaron una Declaración Conjunta, en

donde utilizando la información científica disponible actualmente sobre la cirugía metabólica y bariátrica y sus indicaciones, establecieron que la cirugía metabólica y bariátrica está recomendada para los siguientes individuos con obesidad determinada por clases de obesidad, a saber: personas con obesidad clase 1, 2, 3 según el BMI: Clase 1-de 30.0 a 34.9 BMI, Clase 2- de 35 a 39.9 BMI y Clase 3 de mayor o igual a 40 BMI, con los siguientes parámetros clínicos, según les apliquen:¹

1. aquellos con Índice de Masa Corporal ("BMI", por sus siglas en inglés) igual o mayor a 35 kg/m² sin importar presencia, ausencia o severidad de condiciones comórbidas.
2. aquellos con Diabetes tipo 2 con BMI igual o mayor a 30kg/m².
3. aquellos individuos con BMI de 30-34.9 kg/m² que no logren pérdida de peso sustancial o duradera para mejorar sus co-morbilidades con métodos no-quirúrgicos.
4. aquellos individuos que necesiten la cirugía bariátrica como puente para otras intervenciones quirúrgicas tales como artroplastias, hernias y trasplantes de órganos.
5. La obesidad es una enfermedad crónica que requiere manejo vitalicio después de la operación primaria. Esto incluye procedimientos revisionales y otras terapias incluyendo intervenciones endoscópicas y farmacológicas para lograr el efecto deseado en el tratamiento.
6. Las nuevas guías afirman además que "la cirugía metabólica y bariátrica es actualmente el tratamiento basado en evidencia más eficaz para la obesidad en todas las clases de IMC" y que "los estudios con seguimiento a largo plazo, publicados en las décadas posteriores a la Declaración de Consenso del NIH de 1991, han demostrado sistemáticamente que la cirugía metabólica y bariátrica produce resultados de pérdida de peso superiores en comparación con los tratamientos no quirúrgicos".²

En cuanto al Plan de Salud Gubernamental, la ASES o el Programa Medicaid podrán establecer los requisitos necesarios para la cubierta del servicio de Cirugía Bariátrica, de manera que se proteja la sostenibilidad de este.

Por ende, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el enmendar la Ley 212-2008, en reconocimiento de la necesidad de que la Ley Núm. 212-2008 no se atempera a la realidad actual de la práctica médica en donde los pacientes puedan beneficiarse de las nuevas tendencias científicas existentes para atender sus problemas de obesidad mórbida y de síndrome metabólico. Por consiguiente con la aprobación de esta Ley, se añade la definición de "co-morbilidad", además de atemperar las disposiciones de la Ley 212-2008 a la Declaración Conjunta 2022 de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y

¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9834364/#Sec21title>

² *Id.*

Bariátrica ("ASMBS" por sus siglas en inglés) y Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos ("IFSO" por sus siglas en inglés) relacionadas con las recomendaciones clínicas para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida, según las clasificaciones clínicas de Obesidad Clase 1, 2 o 3, co-morbilidades y/o y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica, según se establece en dicha legislación y que no sean incompatibles con los parámetros establecidos por el gobierno federal para el Programa Medicaid; ~~establecer que el paciente no necesitará de un referido médico por parte de su médico primario para poder acceder al médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica para consultar o comenzar un plan de tratamiento para atender su condición de obesidad mórbida o de síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica cuando sea médicamente necesario con el fin de evitar retrasar el acceso oportuno del paciente al tratamiento médico adecuado de su enfermedad dentro de las Clases de Obesidad y/o co-morbilidades establecidas y sustentadas en el criterio médico del médico especialista para impedir el poner en alto riesgo la vida del paciente;~~ entre otros asuntos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 212-2008, para que se lea como sigue:

"Artículo 1.- Definiciones-

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán los significados que a continuación se expresan:

(a) Obesidad Mórbida (también conocida como Obesidad Severa o de Alto Riesgo)

- es el exceso de grasa en el cuerpo determinado por un índice de masa corporal

"BMI" por sus siglas en inglés) mayor o igual a treinta y cinco (≥ 35). Este tipo

de obesidad es una condición médica en la que el exceso de grasa corporal es

tan elevado que aumenta de forma grave el riesgo de enfermedades y que

reduce la calidad y expectativa de vida; o que posee alguna co-morbilidad,

irrespectivo que el índice de masa corporal ("BMI") se encuentre entre 30.0 a

34.9, que aumente drásticamente la severidad, las complicaciones de salud y el

1 riesgo de mortalidad del paciente, convirtiendo su obesidad en una
2 enfermedad multisistémica más difícil de tratar, colocando en alto riesgo la
3 vida del paciente.

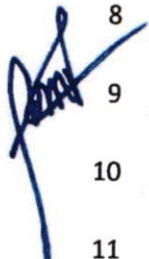
4 (b) Cirugía Bariátrica- Procedimiento quirúrgico para el control de la obesidad, el
5 cual se puede practicar mediante varias técnicas: Bypass Gástrico, Banda
6 Gástrica Ajustable, Balón Intragástrico, Gastrectomía Vertical, (conocido
7 como Sleeve, Manga Gástrica o Tubular Gástrico) Bypass Duodeno Ileal de
8 Anastomosis Única con Gastrectomía en Manga, One Anastomosis Gastric
9 Bypass (OAGB), también conocido como "Mini Bypass Gástrico" o cualquier
10 otro de procedimiento quirúrgico aprobado por el FDA para el control de la
11 obesidad a tono con la necesidad del paciente. El procedimiento del balón
12 intragástrico no estará cubierto para los efectos de esta Ley en el Plan de Salud
13 Gubernamental mientras el Gobierno Federal no incluya el mismo dentro de
14 los servicios provistos por el Programa Medicaid. En el caso de los planes
15 privados establecidos en el Artículo 2 de esta Ley, el procedimiento de balón
16 intragástrico que posea la aprobación de la Administración de Alimentos y
17 Medicamentos de los Estados Unidos (*FDA por sus siglas en inglés*) si estará
18 incluido para efectos de esta definición como parte de sus cubiertas al amparo
19 de esta Ley. En el caso del Plan de Salud Gubernamental, estará sujeto a que
20 esté en cubierta y se cumplan con los requisitos establecidos por ASES o el
21 Programa Medicaid para cubrir y pagar el mismo.

1 (c) Co-morbilidad- es el término utilizado para describir dos (2) o más trastornos
2 o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo
3 tiempo o uno después del otro. La co-morbilidad también implica que hay una
4 interacción entre las dos (2) enfermedades que puede empeorar la evolución
5 de ambas. Ejemplos de trastornos o enfermedades, sin que se entiendan como
6 una limitación son: DT2, hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del
7 sueño, enfermedad cardiovascular (por ejemplo, enfermedad de las arterias
8 coronarias, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular), asma, enfermedad del
9 hígado graso y esteatohepatitis no alcohólica, enfermedad renal crónica,
10 síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, enfermedad por reflujo
11 gastroesofágico, pseudotumor cerebral y enfermedad ósea y articular."Sección
12 ~~2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 212-2008, para que se lea como~~
13 ~~sigue:~~

14 Sección 2- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 212-2008, para que se lea como sigue:

15 "Artículo 2.- Toda compañía de seguro de salud, organización de servicios de
16 salud, incluyendo el Plan de Salud Gubernamental establecido al amparo de la Ley 72-
17 1993, según enmendada y las organizaciones para el mantenimiento de la salud, según
18 definidas en el inciso (x) del Artículo 1 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según
19 enmendada, que realice negocios en la jurisdicción de Puerto Rico, ofrecerá, sujeto a
20 preautorización, dentro de su póliza, el pago para los tipos de cirugía bariátrica, para el
21 tratamiento de la obesidad mórbida permitidos bajo esta Ley. Para esto, la
22 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, las organizaciones de servicios de

1 salud y las organizaciones para el mantenimiento de la salud, según definidas en el inciso
2 (x) del Artículo 1 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada,
3 planificarán y coordinarán dentro del plan de tratamiento del paciente con el médico
4 especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica el período de tiempo para la
5 realización del procedimiento de cirugía bariátrica, el cual será establecido por el
6 Secretario de Salud mediante reglamentación al respecto, excepto cuando el médico
7 especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica certifique que la vida del
8 paciente se encuentra en riesgo inminente. -



9 Se prohíbe a las organizaciones de seguros de salud o demás entidades
10 mencionadas en este Artículo, que para brindar al paciente asegurado la pre-autorización
11 establecida al amparo de este Artículo para recibir los beneficios de los tratamientos de
12 la obesidad mórbida legislados, impongan consultas previas con profesionales de la
13 salud que no sean los recomendados por el médico especialista en medicina bariátrica o
14 en cirugía bariátrica al momento de solicitar dicha pre-autorización. Tampoco se podrán
15 establecer criterios clínicos adicionales o más restrictivos que aquellos permitidos por esta Ley como
16 condición para autorizar una cirugía metabólica o bariátrica.

17 Toda determinación adversa basada en necesidad médica deberá identificar específicamente
18 el criterio clínico utilizado, la información clínica que sustenta la determinación y la razón por la
19 cual el servicio solicitado no cumple con dicho criterio."

20 Sección 3. - Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 212-2008, para que se lea
21 como sigue:

1 "Artículo 3. - Para cumplir con las disposiciones de esta Ley y el pago de los servicios
2 se requerirá lo siguiente:

3 a. La póliza de seguro en Puerto Rico, ya sea pública o privada, cubrirá los tipos de
4 cirugía bariátrica que sean medicamente necesarios, para el tratamiento de la
5 obesidad mórbida según los parámetros establecidos en esta Ley, incluyendo sin
6 que se entienda como una limitación, procedimientos revisionales y otras terapias
7 justificadas, intervenciones endoscópicas y farmacológicas relacionadas con la
8 cirugía bariátrica por alguna complicación asociada a la operación primaria. Una
9 segunda intervención sólo podrá ser autorizada en circunstancias excepcionales,
10 cuando exista una necesidad médica debidamente justificada. En el caso del Plan
11 de Salud Gubernamental ~~del Gobierno~~, una segunda intervención podría
12 autorizarse, siempre y cuando cumpla con los requisitos ya establecidos para esos
13 fines.

14 b. El plan de tratamiento debe ser aprobado por un médico especialista en medicina
15 bariátrica o en cirugía bariátrica. El plan de tratamiento recogerá el compromiso
16 escrito del paciente con el cumplimiento de su tratamiento, incluyendo el
17 protocolo psicológico, y detallará los riesgos, complicaciones y beneficios de la
18 cirugía bariátrica, así como los cambios a largo plazo en los estilos de vida que
19 deberá efectuar el paciente.

20 c. Para la pre-autorización del servicio por la compañía de seguros, organización de
21 servicios de salud, ya sea pública o privada y las organizaciones para el
22 mantenimiento de la salud, según definidas en el inciso (x) del Artículo 1 de la Ley

Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, si es documentado que el paciente que cualifica según los parámetros de "BMI" en las nuevas guías y lo establecido por el Plan de Salud Gubernamental para cubrir y pagar el servicio ha fallado en los métodos no quirúrgicos, el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica será quien determinará aquellos exámenes médicos, tratamientos y/o regímenes necesarios a realizarse a cada paciente por individual antes de realizarse la cirugía bariátrica recomendada.

d. Será el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica quien determine la preparación quirúrgica necesaria para que el paciente mejore su co-morbilidad, los métodos no quirúrgicos utilizados por el paciente para lograr una pérdida de peso sustancial o duradera o una mejora de su co-morbilidad y los problemas encontrados bajo los cuales no lograron su cometido que llevan a la recomendación del procedimiento de cirugía bariátrica a utilizarse con dicho paciente; además de especificar si existen co-morbilidades en el paciente que se agravan con la obesidad mórbida y que cumpla con los requisitos establecidos por ASES o el Programa Medicaid para cubrir y pagar el mismo.

e. En cuanto a la instalación de salud en que se realizará la cirugía bariátrica:

1. Debe contar con la acreditación del Programa Conjunto conocido como el Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP, por sus siglas en inglés), el cual es una iniciativa conjunta de acreditación establecida por la *American College of Surgeons* (A.C.S.) y la *American Society for Metabolic and Bariatric Surgery* (A.S.M.B.S.),

1 las cuales son entidades reconocidas a nivel nacional por agencias federales
2 como Medicare, además de aseguradoras y entidades internacionales,
3 dedicadas específicamente en acreditar centros con programas de cirugía
4 bariátrica, los cuales son claves para la calidad en la atención y seguridad
5 clínica del paciente bariátrico.

6 2. Disponibilidad 24/7 de un equipo médico institucional para responder a
7 eventos clínicos, el cual estará compuesto, pero no se limita a: cirujano
8 bariátrico, intensivistas, especialistas en cuidado crítico, anestesiólogos,
9 nefrólogos y emergenciólogos. Así como personal de enfermería para pacientes
10 ambulatorios y recluidos, adiestrado, en el manejo de pacientes con obesidad
11 mórbida y bariátricos.

12 3. Equipo e instrumentos para el cuidado de pacientes con obesidad mórbida
13 incluyendo: camas dedicadas, sillas de ruedas, mesas de sala de operación,
14 facilidades radiológicas (ct scanner >350 lbs.; equipo de levantamiento con
15 capacidad >450 lbs.) e instrumentos quirúrgicos.

16 4. Servicio de ambulancia interno o contrato formal con una compañía de
17 ambulancia equipada para manejar a la población bariátrica.

18 5. Protocolos escritos para todo evento de manejo de pacientes bariátricos,
19 criterios de selección de pacientes para el Programa y el Comité encargado de
20 administrar estos criterios, servicios de rehabilitación post cirugía, grupos de
21 apoyo, plan de seguimiento y educación al paciente.

6. Cumplir con los requisitos del Plan de Salud Gubernamental para cubrir y pagar el servicio.

Programas de calidad automatizados para recopilar, analizar y mantener datos relacionados con el Programa Bariátrico. El Departamento de Salud, por reglamento, establecerá la información e índices que deberán recopilarse, entre los cuales se hallarán encuestas de satisfacción al paciente, tasa de mortalidad, número y tasa de pacientes que requieren ser reoperados dentro de treinta (30) días, luego de efectuada la cirugía bariátrica inicial, número y tasa de pacientes que deben ser readmitidos dentro de los treinta (30) días, luego de la cirugía bariátrica; estadía hospitalaria promedio, luego de la cirugía bariátrica inicial; complicaciones ocurridas dentro de treinta (30) días de ocurrida la cirugía bariátrica; pacientes que mantienen más del cincuenta por ciento (50%) de la pérdida de peso, por espacio de dos (2) años o más, luego de la cirugía."

f. La póliza de seguro, sea pública o privada, tendrá requisitos uniformes a tono con lo dispuesto en esta Ley, excepto en el caso del Plan de Salud Gubernamental que puede establecer requisitos diferentes para cubrir o pagar el servicio.

Para los planes de salud privados sujetos a la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, los criterios clínicos de elegibilidad establecidos en esta Ley constituirán los criterios mínimos uniformes aplicables para cirugía metabólica y bariátrica. Ninguna entidad podrá adoptar, mediante póliza, contrato, política médica, manual de utilización u otro instrumento, criterios clínicos de elegibilidad más restrictivos que los establecidos en esta Ley. No obstante, podrán establecerse requisitos administrativos razonables dirigidos a documentar el cumplimiento con estos criterios, siempre que dichos requisitos no creen condiciones

clínicas adicionales, modifiquen los criterios de elegibilidad ni provoquen retrasos irrazonables en el tratamiento.

Sección 4.-Reglamentación

Se autoriza al Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, al Comisionado de Seguros y a la Administración de Seguros de Salud a aprobar la reglamentación necesaria para llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley.

Sección 5.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley, aunque se deje sin efecto, anule,

1 invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin
2 efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.

3 Sección 6. -Vigencia.

4 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. En el caso
5 de la extensión de los beneficios legislados al amparo de esta Ley, serán efectivos para
6 todo contrato de seguro de salud, plan médico, cubierta, póliza o contrato de servicios de
7 salud, o su equivalente en el sector privado, en Puerto Rico, que sea nuevo o renovado
8 luego de entrada en vigor esta Ley. En el caso del Plan de Salud Gubernamental, la
9 extensión de los beneficios legislados al amparo de esta Ley serán efectivos al momento
10 de la negociación de un nuevo contrato o dentro del proceso de renovación acordado
11 dentro del contrato vigente con las aseguradoras que brindan servicios dentro de dicho
12 Plan.